

Lapsy, *relapsy* i AVE

Pierwszy łyk po 3 miesiącach abstynencji to **lapsus**, nie **nawrót**. Co decyduje o tym, czy stanie się jednym czy drugim, dzieje się w głowie w ciągu 5 minut po nim.

CZAS: 25 min czytanie + omówienie Psychoedukacja — bez skali

ŹRÓDŁO: Marlatt & Gordon (1985); Witkiewicz & Marlatt (2007)

JAK UŻYWAĆ

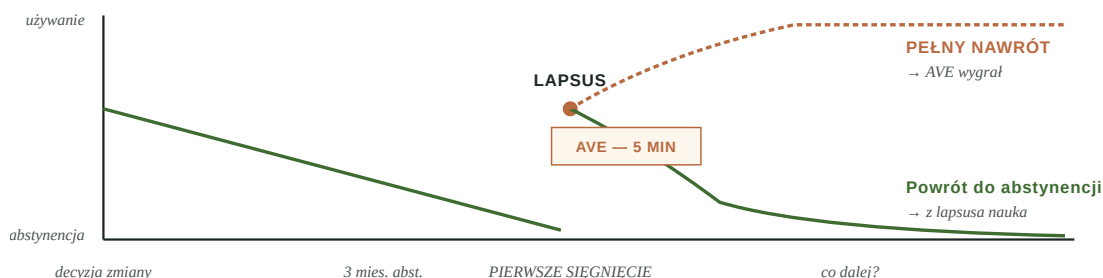
Karta wyjaśnia **trzy pojęcia**, które często mylą się w głowie pacjenta: *lapsus* (jednorazowe sięgnięcie), *relaps* / *nawrót* (powrót do wzorca używania), *efekt naruszenia abstynencji* (AVE — mechanizm między pierwszym a drugim). Cel karty: zobaczyć, że **lapsus nie musi** przejść w **nawrót** — to *decyzja*, nie nieunikniony los. Czytaj raz, wracaj zawsze po sięgnięciu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Marlatt i Gordon (1985) opisali **efekt naruszenia abstynencji** (ang. *abstinence violation effect*, AVE) — mechanizm psychologiczny w pierwszych minutach po pierwszym sięgnięciu po długim okresie wstrzemięźliwości. Pacjent zwykle doświadcza **silnego wstydu + atrybucji wewnętrznej** („jestem do niczego, zawiodłem/am wszystkich”). To *nasila* używanie — jako sposób na uciszenie wstydu. **70% lapsów przeradza się w pełny nawrót** u osób bez wiedzy o AVE; **30%** u osób z wiedzą i ustalonym scenariuszem (Witkiewicz & Marlatt 2007).

01

Trzy pojęcia — różnica w jednej grafice



LAPSUS

Jednorazowe sięgnięcie. Pojedynczy łyk / lufa / kreska. *Nie jest nawrotem* — to wydarzenie.

RELAPS / NAWRÓT

Powrót do wzorca używania. Dni, tygodnie. *Jest powrotem do choroby*, ale nadal odwracalnym.

AVE

Mechanizm wstydu + atrybucji wewnętrznej w 5 min po lapsus. *Decyduje, w którą stronę pójdziesz.*

02 ✕ Anatomia AVE — co dzieje się w 5 minut po lapsus

CO MYŚLI MÓZG „Z AVE”

„Zawiodłem/-am wszystkich.” (*atrybucja globalna*)
„To dowód, że się nie da.” (*katastrofizacja*)
„Skoro już piłem/-am, to dopiję butelkę.” (*efekt „nic mi się nie należy”*)
„Jestem do niczego.” (*samoosąd*)

→ wstyd → szukanie ulgi → kolejne sięgnięcie

CO MYŚLI MÓZG „BEZ AVE”

„Sięgnąłem/-am — to się zdarzyło.” (*atrybucja zewnętrzna*)
„To jedno wydarzenie, nie cała ścieżka.” (*specyficzność*)
„Co mnie do tego doprowadziło? Co mnie nauczyło?” (*refleksja*)
„Wracam do planu. Następnym razem zrobię X inaczej.” (*plan*)

→ analiza → kontakt z terapeutą → powrót

03 📋 Pięć zasad bezpiecznego przejścia przez lapsus

1 • Bez biczowania. Wstyd nasila nawrót — nie zmniejsza go. Zamiast „jestem do niczego” → „zdarzyło się”.

2 • Bez rozszerzania. NIE „skoro już piłem/-am, to dopiję butelkę”. Pierwsze 30 minut po lapsus = krytyczne.

3 • Telefon w pierwszej godzinie. Do osoby z listy wsparcia (karta „Sieć wsparcia”). Nie pisz — zadzwoń.

4 • Kontakt z terapeutą do 48 h. Lapsus to materiał terapeutyczny, nie wstyd do ukrycia.

5 • Analiza w ciągu tygodnia. Co poprzedziło lapsus — godziny, dni? Jakie sygnały zignorowałem/-am? Co zmienię? *To nie egzamin — to lekcja.*

04 ✎ Co dziś o tym wiem — krótka notatka

MÓJ SCENARIUSZ, JEŚLI SIĘ PRZYTRAFI LAPSUS

— jedno zdanie, czas teraźniejszy

Klucz: Witkiewicz & Marlatt (2007) w analizie 1276 epizodów lapsus wykazali, że **różnica między lapsus a pełnym nawrotem** w 70% przypadków zależy nie od głębokości uzależnienia, tylko od *reakcji poznawczej w pierwszych 5 minutach*. Pacjenci, którzy umieli zastosować atrybucję zewnętrzną i specyficzną („sięgnąłem — to jedno wydarzenie”), wracali do abstynencji w 70% przypadków. Pacjenci z AVE — w 30%. Wiedza o AVE to **najtańsza interwencja** w terapii uzależnień.